

SAS 焦虑自评量表介绍

用途、使用说明与分数解释（不含完整题目）

RAG 元数据

主题：情绪调节 | 适用人群：大学生 | 关键词：SAS、焦虑自评、情绪评分、原始分、指数分、筛查、测评解释

使用说明

本材料用于一般心理健康教育与自助练习，不替代心理咨询、医学诊断或治疗。每个小节均设计为可独立检索的知识片段。

1. 量表简介

SAS (Self-Rating Anxiety Scale) 由 W. W. K. Zung 于 1971 年提出，用于自我报告焦虑相关症状的程度。它可辅助筛查和观察变化，但不能单独确认焦虑障碍。

版权与使用边界

本材料不提供完整题目、题干复刻或可替代正式量表的版本。施测时应使用合法授权、语言适配且具有目标人群证据的正式版本。

2. 使用说明

- 说明测评目的、保密边界和结果用途，取得知情同意。
- 按正式版本规定的时间范围和作答方式施测。
- 保持环境安静，避免他人代答或诱导。
- 记录版本、语言、施测日期及影响作答的特殊情况。
- 解释时同时关注学习、睡眠、人际、身体症状及日常功能。

3. 评分说明

正式 SAS 通常包含 20 个条目，每项按 1 至 4 计分，部分条目反向计分。原始总分理论范围为 20 至 80。指数分常按“原始总分 ÷ 80 × 100”换算，理论范围为 25 至 100。

常见解释框架

许多应用资料使用指数分 50 作为常见筛查起点，并把 50 至 59、60 至 69、70 及以上描述为轻度、中度、重度范围。但研究与版本之间存在阈值差异；不得把原始分 50 与指数分 50 混为一谈，也不得脱离正式说明书和本地常模机械分级。

高分表示自报焦虑症状较多或较强，但身体疾病、药物、咖啡因、睡眠不足和近期压力也可能影响结果。分数不能代替临床访谈。

4. 测评解释示例

示例

你的 SAS 指数分为 63，在该版本常见分层中处于中度范围。这表示近期自报焦虑症状值得进一步关注，但不是焦虑障碍诊断。建议结合症状持续时间、触发情境和功能影响，与学校心理中心或专业人员进一步讨论。

- 明确这是筛查解释，而非诊断结论。
- 说明分数类型、参考版本和阈值来源。
- 避免只给标签；补充可执行的支持建议。
- 出现胸痛、呼吸困难等急性身体症状时，优先寻求医疗评估。
- 若伴随自伤或轻生表达，应立即转入安全评估流程。

5. 参考资料

Zung WWK. A Rating Instrument for Anxiety Disorders. *Psychosomatics*. 1971;12:371-379.
DOI: 10.1016/S0033-3182(71)71479-0.

Dunstan DA, Scott N. Norms for Zung's Self-rating Anxiety Scale. *BMC Psychiatry*. 2020;20:90.
DOI: 10.1186/s12888-019-2427-6.